

Sprawdzanie nie uspokaja — *wzmacnia lęk*

*Lustra, pomiary, dotyk, porównania — rytuały dające chwilową ulgę, ale wzmacniające nadwartościowanie.
Mechanizm jak w OCD: czek → ulga → kompulsja.*

CZAS: 30 min identyfikacji + tygodnie pracy z redukcją

REALIZACJA: faza 2 CBT-E, równolegle z pracą nad nadwartościowaniem

ŹRÓDŁO: Shafran, Fairburn, Robinson & Lask (2004, *Int J Eat Disord*); Fairburn (2008, rozdz. 8); Mountford i in. (2006)

JAK UŻYWAĆ

Sekcja 01 — **typy body checking** (lustro, pomiary, dotyk, porównania, ważenie) + mechanizm OCD-podobnej pętli. Sekcja 02 — **siedem kroków redukcji**: identyfikacja → monitorowanie → eliminacja stopniowa. Sekcja 03 — **arkusz „moje rytuały”**.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Body checking — obsesyjne, rytualne sprawdzanie ciała w celu „kontroli” wagi lub kształtu. Typowe: częste ważenie (kilka razy dziennie), pomiary obwodów (talía, uda, ramiona), dotyk wystających kości (obojczyki, biodra, żebra), spoglądanie w lustro w określonych pozycjach, porównywanie się z innymi, mierzenie ubrań, fotografowanie ciała. Mechanizm — analogiczny do OCD: *lęk → czek → chwilowa ulga → wzmocnienie kompulsji*. Shafran i in. (2004): body checking *wzmacnia* nadwartościowanie zamiast je redukować — pacjent „uczy się”, że bez sprawdzania nie da się żyć. Bez redukcji checking — nadwartościowanie się utrzymuje, niezależnie od pracy poznawczej.

01 Typy body checking + mechanizm utrzymywania

TYP	TYPOWE RYTUAŁY W AN
Ważenie	Kilka razy dziennie, w określonych warunkach (rano, po toalecie, na czczo). Często „na różnych wagach”, żeby „sprawdzić”. W skrajnych przypadkach ważenie po każdym posiłku, kontrola ubytków.
Lustro	Patrzanie w lustro w określonych pozycjach (z boku, na brzuch, na uda), w określonym oświetleniu. Skupianie się na „problematycznych miejscach” — pomijanie reszty. Często 30+ minut dziennie łącznie.
Dotyk / pomiary	Dotyk obojczyków, biodrowych kości, żeber, kręgosłupa — „czy nadal wystają”. Mierzenie obwodów (talía, uda, ramiona), sprawdzanie luzu ubrań, „czy spodnie nadal się luzują”.
Porównywanie	Porównywanie się z innymi (na żywo, w mediach społecznościowych, w lustrach sklepowych). Szczegółne zwracanie uwagi na osoby o podobnej budowie. Często skanowanie ulicy/szkoły/pracy.

Pętla OCD-podobna. Lęk („czy nie przytyłem/-am?”) → czek (waga, lustro, dotyk) → chwilowa ulga („nadal kontrola”) → wzmocnienie kompulsji → kolejny lęk. Bez przerwania pętli — nadwartościowanie się utrzymuje.

- 03

M

RYTUAŁ (KONKRETNIE)	ILE RAZY DZIENNIE	WYZWAŁACZ (KIEDY, PO CZYM)	PLAN OGRANICZENIA

Klucz: body checking *nigdy* nie jest neutralne — każdy rytuał wzmacnia nadwartościowanie. Pacjent często nie wie, jak często sprawdza ciało — to automatyzm. Tygodniowy monitorowanie (sekcja 03) zwykle ujawnia 30–60 epizodów dziennie. Po ograniczeniu rytuałów lęk wzrasta przez 2–4 tygodnie, potem trwale maleje (Shafran i in., 2004). **Komunikat dla pacjenta:** „*sprawdzanie nie daje Ci kontroli. Wzmacnia lęk. Jak każda kompulsja: im więcej, tym gorzej. Ograniczenie będzie trudne przez 2–4 tygodnie — potem wolność*”.

△ **Body checking często idzie w parze z body avoidance** — pacjenci mogą jednocześnie obsesyjnie sprawdzać i unikać. Np. częste ważenie + brak luster w domu + luźne ubrania. Oba podtrzymują nadwartościowanie. Praca z oboma równoległe (zob. karta body-avoid).